

Traitement de la Douleur en Cancérologie

Protocoles, Évaluation et
Prise en Charge Globale

Une Urgence Humaniste et Clinique

“Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle.”

— Définition IASP

- Symptôme le plus fréquent chez le patient cancéreux.
- Douleur chronique présente chez 60 à 90% des patients.
- Impact majeur : Retentissement psychologique, affectif et social.
- Signification : Souvent interprétée comme un signe ou signe de récidence ou d'échec thérapeutique.
- Impératif : Nécessité d'une prise en charge individuelle.

La Temporalité de la Douleur : Aiguë vs Chronique

Douleur Aiguë (Signal d'alarme)



- Apparition brutale.
- Persiste quelques heures à quelques jours.
- Révélatrice (ex: fracture, occlusion).
- Cède généralement aux antalgiques.

Douleur Chronique (Maladie destructrice)



- Durée > 3 mois (Syndrome douloureux chronique).
- Mécanismes souvent mixtes.
- Retentissement physique et psychique profond.
- Concerne la majorité des patients en oncologie.

Physiopathologie : Identifier le Mécanisme

1. Nociceptive (Excès de nociception)

- Lésion tissulaire (mécanique ou inflammatoire).
- Stimulation des nocicepteurs.
- Examen neurologique normal.

2. Neuropathique (Désafférentation)

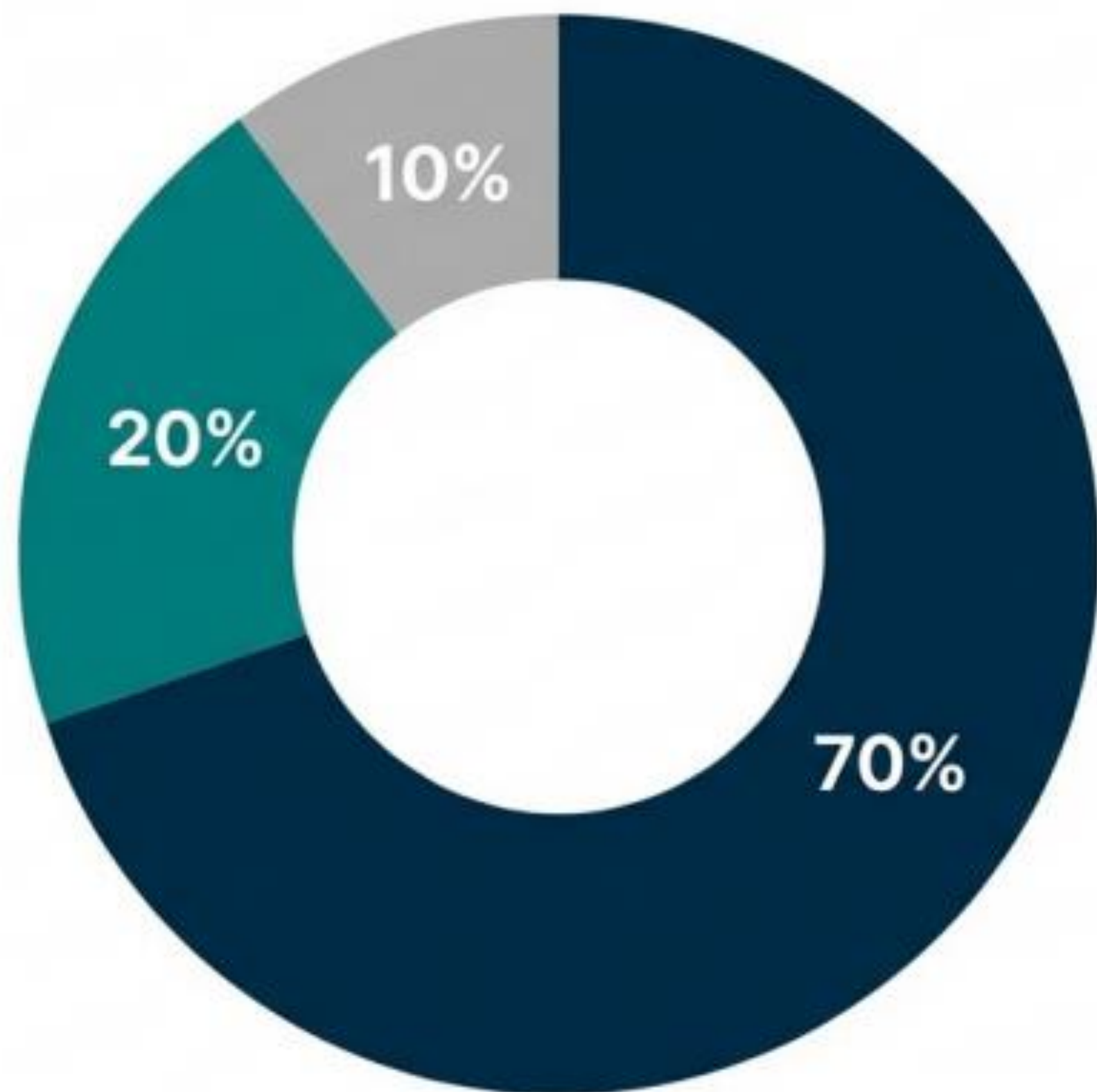
- Lésion du système nerveux (central ou périphérique).
- Sensation : Brûlures, décharges électriques.
- Examen neurologique anormal (DN4).

3. Psychogène

- Rare (psychose).
- L'anxiété et la dépression majorent la perception.

Observation : La douleur cancéreuse est souvent mixte (fond douloureux + accès paroxystiques).

Étiologies : L'Origine de la Souffrance



Liée à l'évolution tumorale

- Compression/Infiltration nerveuse
- Viscérale (occlusion)
- Osseuse (métastases)
- Inflammation des muqueuses.

Liée aux soins (iatrogène)

- Post-chirurgie
- Post-radiothérapie (nécrose)
- Post-chimiothérapie (mucite, neuropathie).

Affection intercurrente

- Arthrose, ostéoporose, etc.

La Démarche Diagnostique

L'Interrogatoire

- Topographie, temporalité, efficacité des traitements antérieurs.

L'Examen Clinique

Physique et neurologique soigneux.
Distinguer Nociceptif vs Neuropathique.

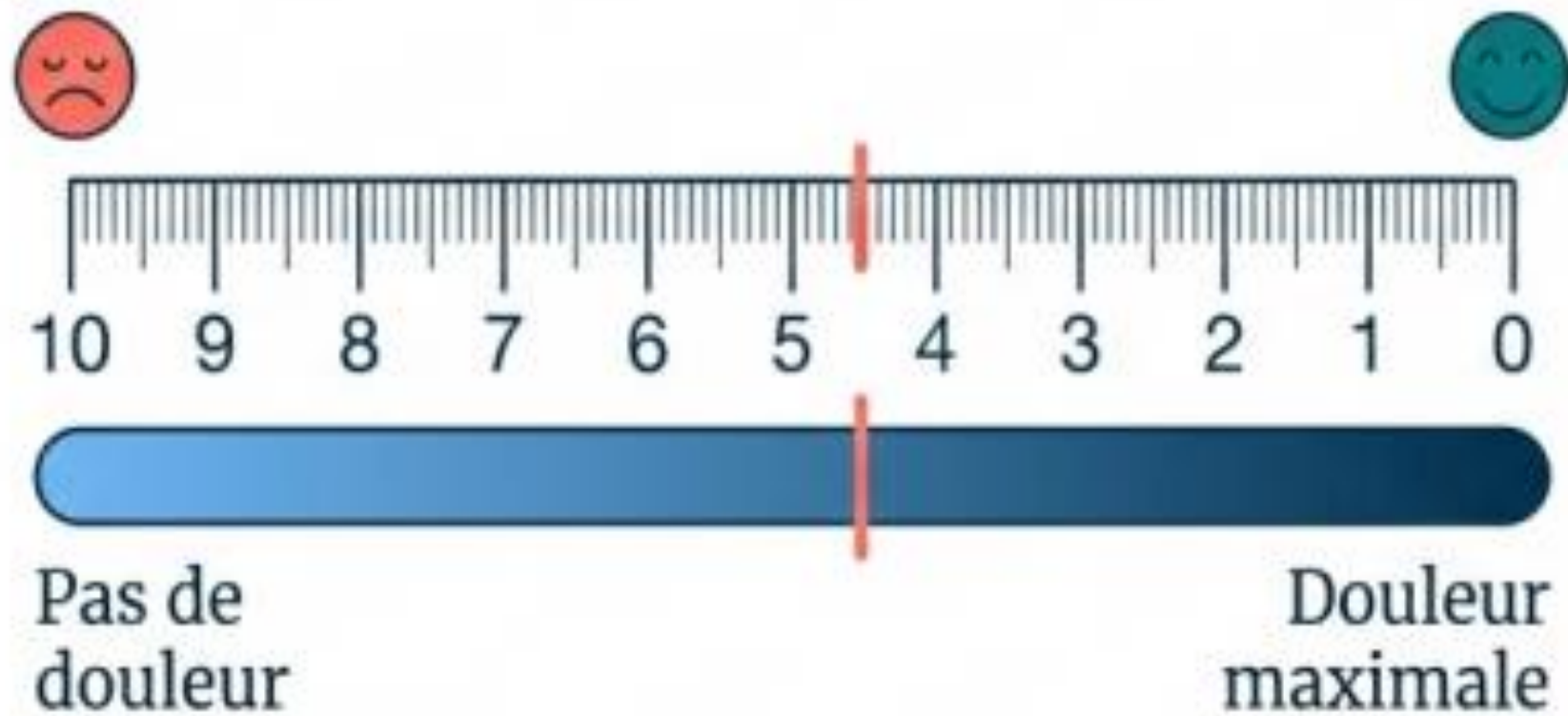
Urgence à éliminer

- Compression médullaire, fracture, occlusion, infection.

Prescrire examens complémentaires si doute.

Évaluation : Quantifier pour Traiter

Outils Unidimensionnels



EVS (Échelle Verbale Simple): 0-4

EVN (Échelle Verbale Numérique): 0-10

EVA (Échelle Visuelle Analogique): 0-10

Outil Spécifique : Neuropathie

The diagram shows a representation of the DN4 questionnaire form. It has a red tab at the top and a teal border. The text on the form is as follows:

INTERROGATOIRE DU PATIENT

Question 1 : Caractéristiques?

Brûlure	☐ Oui	☐ Non
Froid douloureux	☐ Oui	☐ Non
Décharges électriques	☐ Oui	☐ Non

Question 2 : Symptômes associés?

Fourmillements	☐ Oui	☐ Non
Picotements	☐ Oui	☐ Non
Engourdissement	☐ Oui	☐ Non
Démangeaisons	☐ Oui	☐ Non

EXAMEN DU PATIENT

Question 3 : Examen clinique?

Hypoesthésie au tact	☐ Oui	☐ Non
Hypoesthésie à la piqure	☐ Oui	☐ Non

Question 4 : Provoquée?

Le frottement	☐ Oui	☐ Non
---------------	------------------------------	------------------------------

Questionnaire DN4 indispensable pour diagnostiquer la douleur neuropathique.

Principes Généraux de Traitement

Principes généraux:

La Stratégie

- Respecter les 3 paliers de l'OMS.
- Si douleur intense d'emblée :
Attaquer directement au Palier II ou III.

Mode d'Administration

- Voie Orale à privilégier.
- Horaire Fixe : Traiter pour prévenir (ne pas attendre la plainte).
- Contrôle sur le nycthémère (24h).

Suivi & Réévaluation

- Réévaluation périodique et quotidienne.

Sécurité

- Prévention systématique des effets secondaires.

Palier I : Douleurs Légères à Modérées

Paracétamol (1er Choix)

- Posologie : 500mg - 1g toutes les 6h.
- Dose max : 4g/jour (Toxicité hépatique).
- Attention : Risque chez l'alcoolique ou le patient malnutri.

AINS (Anti-inflammatoires)

- Ibuprofène préféré (toxicité gastrique moindre).
- Max 2400mg/j.
- Contre-indications : UGD, insuffisance rénale, asthme, anticoagulant.
- **Note** : Association possible Paracétamol + AINS.



Palier II : Opioïdes Faibles

Pour douleur modérée à intense, ou échec du Palier I

Tramadol

- Max 400 mg/jour.
- Existe en LP (libération prolongée) et injectable.

Dihydrocodéine / Codéine

- Dihydrocodéine : 60 mg toutes les 12h.

Buprénorphine (Temgesic)

- Agoniste partiel (Intermédiaire).
- Sublingual ou Injectable.
- Avantage : Utile en cas d'insuffisance rénale.

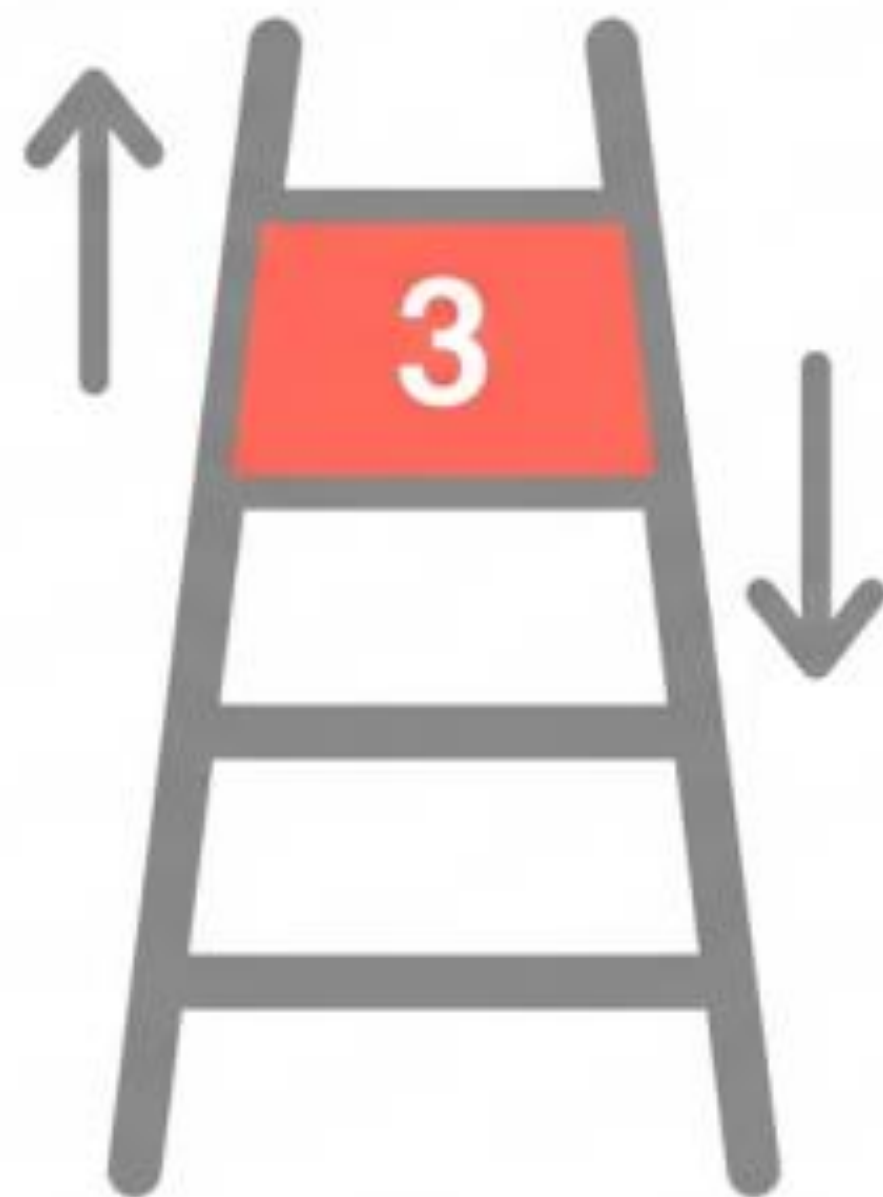
Attention : Effet plafond (Ceiling effect) et association fréquente avec Paracétamol.



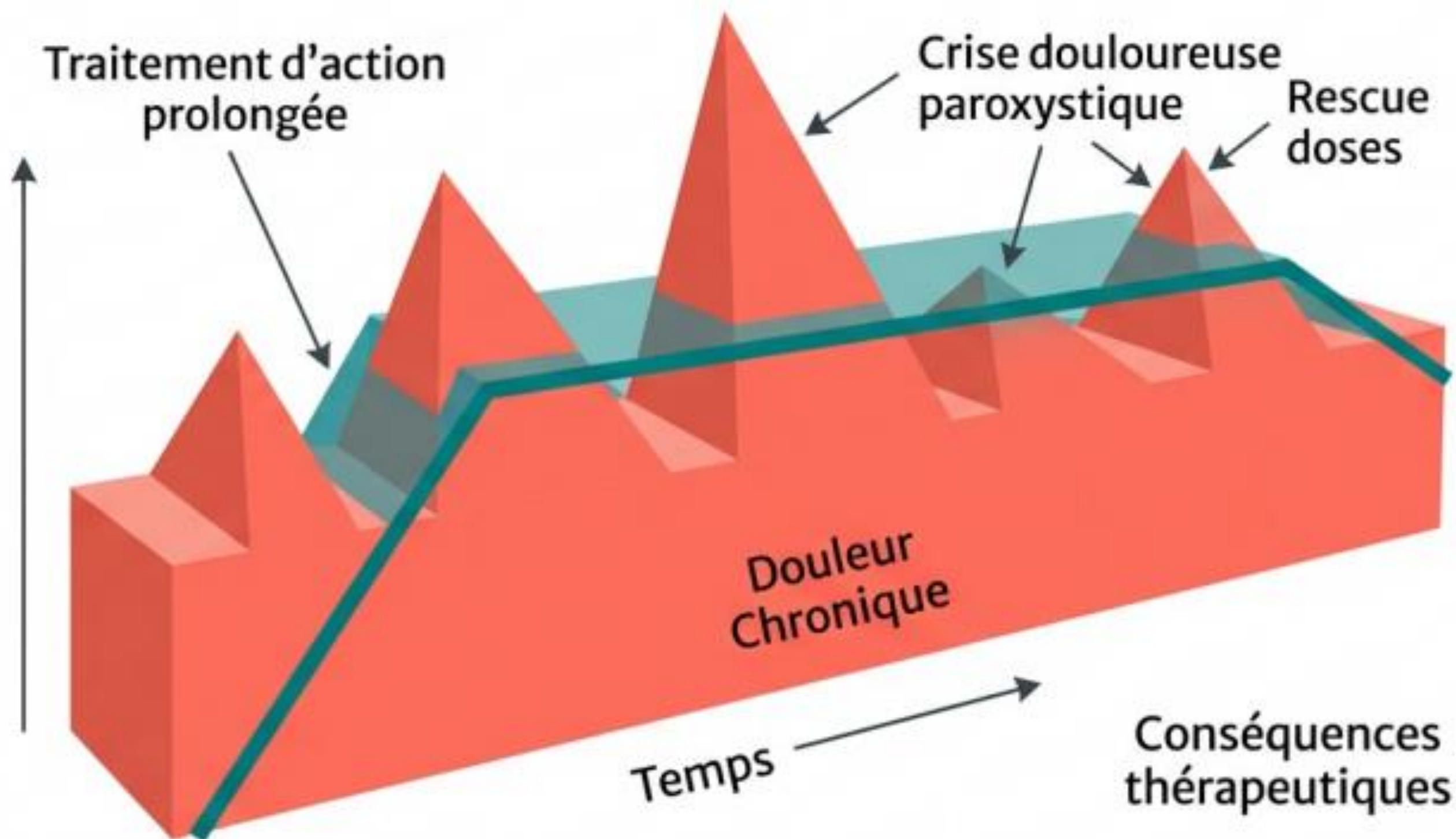
Palier III : Opioïdes Forts

Pour douleur intense d'emblée ou échec du Palier II

- **Morphine (Sulfate de morphine)**
 - La référence. Formes LP (12h) et LI (immédiate).
- **Oxycodone**
 - 2x plus puissant que la morphine orale.
- **Hydromorphone**
 - 7.5x plus puissant que la morphine orale.
- **Fentanyl**
 - Patch transdermique (72h).
 - 100x plus puissant que la morphine orale.



L'Art de la Prescription : Titration et Interdoses



Titration

- Détermination de la dose minimale efficace (24-48h).

Interdoses (Rescue)

- 1/6^{ème} à 1/10^{ème} de la dose quotidienne.
- Forme LI.
- Prise à la demande.

Rotation

- Changer de molécule si résistance ou effets secondaires.

Gestion des Effets Secondaires

<u>Effet</u>	<u>Fréquence/Evolution</u>	<u>Action Requise</u>
Constipation	90% (Inévitable, pas de tolérance).	Laxatifs systématiques dès le début.
Nausées / Vomissements	30-60% (Tolérance en 7-10 jours).	Métoclopramide ou Halopéridol si besoin.
Somnolence	20-60% (Tolérance en 3-5 jours).	Surveiller surdosage / Insuffisance rénale.
Neurotoxicité (Confusion/Hallucinations)		Hydratation + Rotation des opioïdes.

Douleurs Spécifiques et Co-Analgésiques

Douleur Neuropathique

- Anti-épileptiques : Gabapentine, Prégabaline.
 - Antidépresseurs : Amitriptyline (commencer bas, le soir).
 - Local : Patchs Lidocaïne.
-

Métastases Osseuses & Adjuvants

- Os : Biphosphonates, Radiothérapie, Cimentoplastie.
- Corticoïdes : Pour compression ou HIC.
- Anxiolytiques : Pour composante émotionnelle.

Conclusion et Cas Particuliers

Populations Fragiles

- **Sujet Âgé** : Démarrer à 50% de la dose.
- **Insuffisance Rénale** : Éviter morphine (préférer Buprénorphine/Fentanyl).
- **Insuffisance Hépatique** : Limiter Fentanyl.

Message Clé

Le traitement de la douleur fait partie intégrante du traitement du cancer.

Diagnostic Précis + Respect des Paliers OMS + Anticipation des Effets Secondaires = Succès.

Objectif final : Une prise en charge globale et digne.

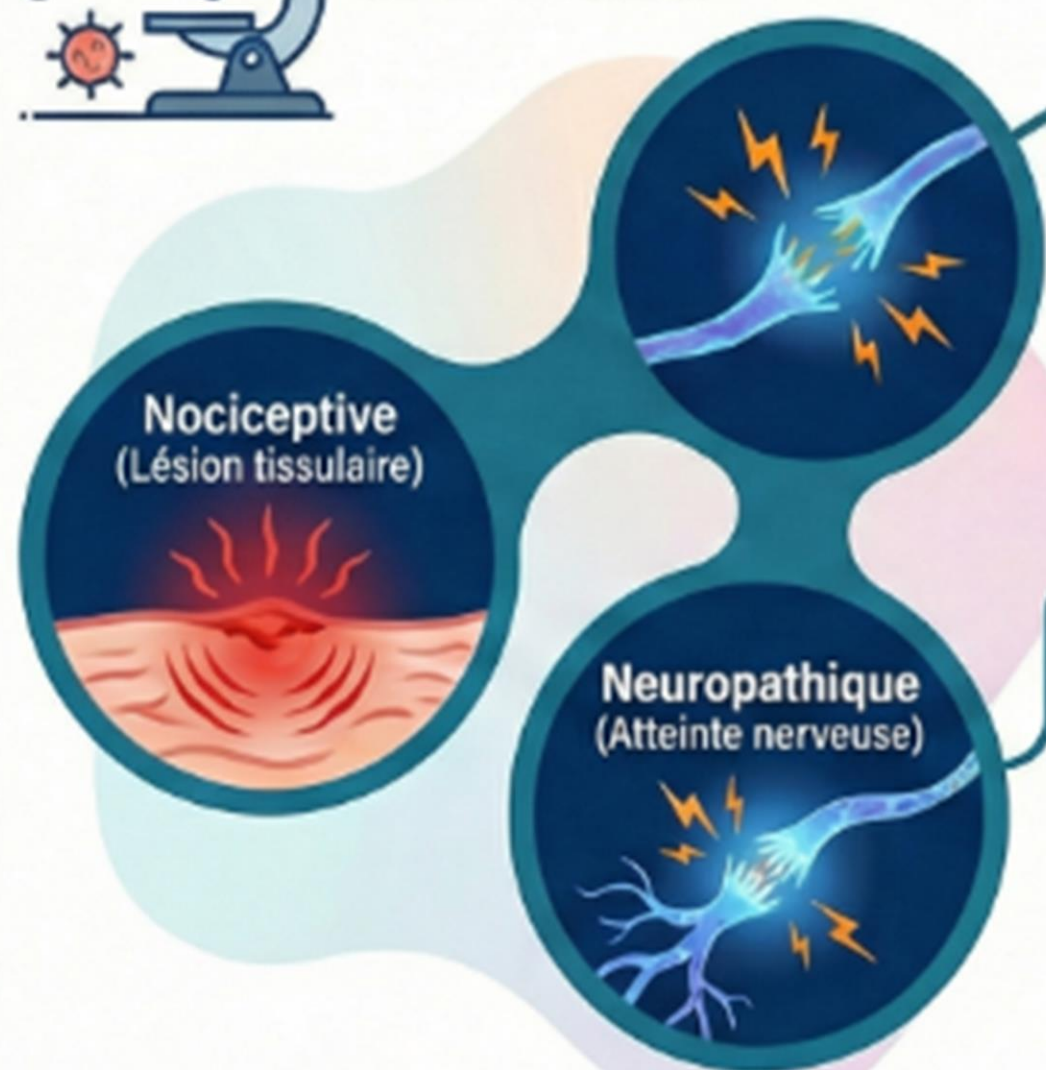
Prise en Charge de la Douleur en Cancérologie : Du Diagnostic au Traitement

La douleur est le symptôme le plus fréquent en oncologie, touchant 60 à 90 % des patients au stade chronique. Une prise en charge réussie repose sur l'identification du mécanisme (nociceptif ou neuropathique) et l'application stricte des paliers thérapeutiques de l'OMS.



Évaluation et Diagnostic

Identifier le mécanisme de la douleur



70 %
des douleurs
liées à la tumeur

La majorité des douleurs proviennent de compressions nerveuses, d'envahissements osseux ou viscéraux.

Évaluer l'intensité via les échelles



Utiliser systématiquement l'EVA (0-10), l'EVN ou l'EVS pour adapter le traitement.



Stratégie Thérapeutique

Respecter les 3 paliers de l'OMS

Monter l'échelle selon l'intensité ou débiter au palier III si douleur d'emblée intense.



Administration à horaires fixes

Traiter durablement sur le nyctémère sans attendre que le patient se plaigne.

70 à 90 %
de constipation
sous opioïdes



Prévenir systématiquement les effets secondaires par des laxatifs quotidiens lors du palier III.

